검진병원	미래의료재단
검진일자	2025-06-18
생년월일	19921103
성명	최진원
회사명	카카오
부서명	

CareLink에서의 결과조회는 검진병원에서 CareLink에 제공한 검진결과 데이터를 바탕으로 구성됩니다. 실제 검진병원에서 제공하는 검진결과 표(지면)의 내용과 검사항목, 검사수치, 참고치 등에 차이가 있을 수 있으므로 단순 참고용으로만 보시기 바랍니다.

건강검진의 필요성

사람은 누구나 건강하게 오래 살기를 원합니다. 현재 우리는 어느 질병이든 조기에 발견하면 완치될 수 있는 최첨단 의학 시대에 살고 있지만, 우리 몸의 어느 부분에 문제가 발생했을 때 병원을 찾는다 면 질병을 치료하는데 많은 비용과 시간이 걸리는 것을 감안해야합니다. 건강검진이란 것은, 건강한 사람일수록 꾸준하게 자신의 건강을 관리함으로써 건강을 지킬수 있는 자기관리 방법입니다. 그러므로 정기적인 건강검진을 통하여 자신의 건강상태를 잘 인지하고 지속적인 건강관리를 실천함으로써 더욱 활기찬 삶을 도모할 수가 있으며, 질병을 조기 진단하여 효과적인 치료와 예방하는 것이 본인과 가족 모두의 행복을 보장하는 것입니다

종합 소견

[종합소견]
종합검진 결과에 대한 종합소견입니다.

◈ 위내시경 검사에서 식도, 위, 십이지장까지 관찰하였고 특이소견 관찰되지 않습니다.
속쓰림, 소화불량 등의 증상이 없으면 1년 후 정기검사 받으시기 바랍니다.

◈ 대장내시경 검사에서 특이소견이 관찰되지 않습니다.
질환에 대한 가족력이 없으면 3~5년마다 정기적인 검사 권장합니다.

◈ 뇌 MRI T2WI 검사 결과 뇌실질에 특이소견 보이지 않습니다.

◈ 심장 초음파 검사상 특별한 이상 소견 없습니다.
좌심실 이완기능 수축기능{박출률 67\% (정상범위 56~78\%)}은 정상 범위입니다.

◈ 전립선 초음파 검사상 전립선 석회화 소견입니다.
전립선 석회화는 비교적 흔한 소견이며 특별한 임상증상이 없으면 추적검사만으로도 충분합니다.

◈ B형간염 검사상 HBsAb 양성으로 항체가 형성된 상태이며, 예방접종은 불필요한 상태입니다.

기초 검사

신체계측 및 혈압검사

비만은 체내에 지방이 과다하게 축적된 상태를 말하며, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 지방간, 뇌혈관질환 등의 만성질환을 유발할 수 있으므로 적절한 관리가 필요합니다.

혈압은 활동상태, 안정상태등에 따라 수시로 변동하므로 한번의 측정으로 고혈압을 진단하기는 어렵습니다. 충분히 안정을 취한 후 혈압을 측정하고 정기적으로 측정하는것을 권장합니다.

관련 질환 비만, 고혈압, 저혈압

검사항목	2025	참고치
신장 (cm)	176	
체중 (kg)	67.0	
체질량지수 (BMI)	21.6	18.5~22.9
허리둘레(복위) (cm)	79.5	90 미만
수축기혈압 (mmHg)	103	120 미만
이완기혈압 (mmHg)	64	80 미만

안과 검사

안저검사는 눈의 안쪽 구조물을 직접 촬영하는 검사이며, 안압검사는 눈 안쪽의 압력을 측정하는 검사입니다. 안저 및 안압검사는 고혈압성 또는 당뇨병성 망막질환이나 시신경 이상유무, 녹내장, 백내장, 등을 검사할 수 있습니다.

관련 질환 근시/원시, 녹내장, 백내장, 망막질환 등

검사항목	2025	참고치
교정시력(좌)	1.2	
교정시력(우)	1.2	
안압(좌) (mmHg)	13	10-21

안압(우) (mmHg)	15	10-21
안저	안저검사 결과 특이소견 없습니다.	

청력 검사

청력검사를 통해 청력손실의 유무와 정도를 평가할 수 있으며, 40dB 이상일 경우 일상생활에 지장이 있을 수 있으며, 수치가 커질수록 난청의 위험이 있습니다.

관련 질환 청력장애

검사항목	2025	참고치
청력좌(500Hz) (dB)	25	0-30
청력우(500Hz) (dB)	25	0-30
청력좌(1000Hz) (dB)	15	0-30
청력우(1000Hz) (dB)	15	0-30
청력좌(2000Hz) (dB)	15	0-30
청력우(2000Hz) (dB)	15	0-30
청력좌(4000Hz) (dB)	15	0-30
청력우(4000Hz) (dB)	15	0-30

심폐기능 검사

심전도 검사

심전도는 심장의 전기적 활동 상태를 그래프로 기록한 검사입니다.
부정맥, 협심증, 심근경색 등의 허혈성 심장병의 발견 및 진단에 도움을 주며, 증상에 따라 전문의의 진료가 필요할 수 있습니다.

관련 질환 심비대, 부정맥, 심근경색 등

검사항목	2025
심전도 검사	심전도 검사 결과 특이소견 없습니다.

흉부X선 검사

흉부 X선 촬영은 폐부위, 심장, 종경동, 횡격막 등의 이상을 검사하기 위해 촬영하게 되며, X선 투과방향에 위치하는 구조물들이 겹쳐보여 병변의 판독이 어려울 경우 CT 등의 추가 검사가 필요할 수 있습니다.

관련 질환 폐 및 흉부질환

검사항목	2025
흉부X선 촬영	흉부 단순촬영 검사 결과 양폐야에 보이는 특이소견은 없습니다.

간기능 검사

간기능은 간질환, 약물복용, 음주, 비만 등에 의해 변화될 수 있습니다.
빌리루빈의 증가는 간질환, 황달 등과 관련 있지만 공복시 단순 증가할 수 있으며, 총단백 및 알부민의 변화는 간질환, 신장질환 등과 관련이 있을 수 있습니다.

관련 질환 급·만성간염, 지방간, 알콜성간장애, 황달, 간경변증

검사항목	2025	참고치
총단백(Total protein) (g/dL)	7.2	5.8-8.3
알부민(Albumin) (g/dL)	4.6	3.1-5.3
글로블린(Globulin) (g/dL)	2.6	2.0-3.5
A/G비율	1.8	1.0-2.3
총빌리루빈(Total bilirubin) (mg/dL)	1.40	0.2-1.4
직접빌리루빈(Direct bilirubin) (mg/dL)	0.39	0-0.4
간접빌리루빈(Indirect bilirubin) (mg/dL)	1.01	0-0.8
AST(SGOT) (IU/L)	22	0-40
ALT(SGPT) (IU/L)	20	0-40
³GTP (IU/L)	15	5-63
알칼리성 인산가수 분해효소(ALP) (IU/L)	55	30-130
유산탈수소효소(LDH) (U/L)	134	100-497

간염표지자 검사

간염표지자 검사는 바이러스성 간염에 대한 검사입니다.

A형 간염 항체(HAV Ab)와 B형 간염 표면항체(HBs Ab)가 양성인 경우는 면역이 있는 것을 의미하므로 예방접종을 맞으실 필요가 없습니다.

B형 간염 항원(HBs Ag) 양성인 경우는 바이러스 보균 상태를 의미하고, B형 간염 항원/항체 모두 음성인 경우는 예방접종을 권유합니다.

C형 간염 항체(HCV Ab)양성인 경우는 과거감염 또는 현재 보균 상태일 수 있으므로 추가검사가 필요할 수 있습니다.

관련 질환 간염

검사항목	2025	참고치
HBs Ag(B형 간염 바이러스 항원)	음성	음성
HBs Ab(B형 간염 바이러스 항체)	양성	
HCV Ab(C형 간염 바이러스 항체)	음성	음성

일반 혈액 검사

일반혈액 검사는 혈액 내 존재하는 세포(적혈구, 백혈구, 혈소판 등)의 특성을 분석하는 검사로 전반적인 건강상태를 나타내며, 질환의 선별검사와 추적검사로 이용됩니다. 일반적으로 혈액질환, 빈혈, 적혈구 증가증, 백혈병,혈액응고이상 등의 여부를 살펴볼 수 있습니다.

관련 질환 급·만성염증, 빈혈, 출혈성질환, 기타혈액질환, 각종백혈병, 알레르기질환

검사항목	2025	참고치
적혈구수(RBC) (x10^6/uL)	4.85	4.0-6.3
혈색소(Hb) (g/dL)	15.1	13-18
적혈구용적(Hematocrit) (%)	44.8	38-53
평균적혈구용적(MCV) (fl)	92.4	80-100
평균적혈구혈색소량(MCH) (pg)	31.1	27-34
평균적혈구혈색소농도(MCHC) (g/dL)	33.7	31-38
적혈구분포계수(RDW) (%)	12.3	11.5-15.5
혈소판수(PLT) ($x10^3$/uL)	233	130-400
혈소판백분율(PCT) (%)	0.24	0.15-0.32
평균혈소판용적(MPV) (fl)	10.1	7.4-12.0
혈소판분포폭(PDW) (fl)	11.1	10.0-18.0
백혈구수(WBC) ($x10^3$/uL)	3.67	4.0-11.0
분획호중구(Seg.Neutrophil) (%)	40.8	40-75
봉상호중구(Band neutrophil) (%)	0	0-9
임파구(Lymphocyte) (%)	45.5	15-45
단핵구(Monocyte) (%)	8.2	0-11
호산구(Eosinophile) (%)	4.1	0-7

호염기구(Basophile) (%)	1.4	0-2
후골수구(metamyelocyte) (%)	0	0-0
골수구 (Myelocyte)	0	
전골수세포(promyeloyte) (%)	0	0-0
유핵적혈구 (%)	0	0-0

• 종양표지자 검사

종양표지자 검사는 혈액을 통해 간접적으로 암의 유무를 평가하는 검사로, 진단적 가치보다는 치료효과의 판정, 재발유무를 평가하는데 도움이 될 수 있습니다.

관련 질환 간암, 간경변, 대장암, 직장암, 폐암, 전립선암, 비대증, 난소암, 췌장암, 간담도계암, 백혈병

검사항목	2025	참고치
AFP (ng/mL)	2.06	0-20
CEA (ng/mL)	1.07	0-6
PSA (ng/mL)	0.293	0-4
CA19-9 (U/mL)	0.45	0-37

• 철 결핍성 빈혈 관련 검사

빈혈관련 검사는 체내 철분 저장 정도를 평가하는 검사입니다.
철결핍성 빈혈에서 혈중 철분 및 Ferritin은 감소하고 TIBC는 증가되며, 최소 3개월 이상 철분제제나 철분이 풍부한 식이를 권장합니다.

관련 질환 철결핍성빈혈, 만성질환에 의한 빈혈

검사항목	2025	참고치
혈청철(Fe) (㎍/dL)	113	49-182
불포화 철결합능(UIBC) (㎍/dL)	156	130-300
총결합능(TIBC) (㎍/dL)	269	240-457

신장기능/감염성 검사

신장기능 검사

신장은 체내 노폐물을 배출하는 중요한 기능을 하며, 요소질소와 크레아티닌의 증가는 신장기능 저하를 의심할 수 있습니다.

관련 질환 신부전증, 신장기능장애

검사항목	2025	참고치
요소질소(BUN) (mg/dL)	9	5-26
크레아티닌(Creatinin) (mg/dL)	0.81	0.3-1.5
B/C비율	11	

소변 검사

소변검사는 신장, 방광, 요도의 질환을 진단하기 위한 검사입니다.
주로 혈뇨 및 요로 감염여부를 평가할 수 있으며, 단백뇨의 경우 신장기능 저하를 의심할 수 있습니다.

관련 질환 방광염, 요도염, 요로결석, 당뇨병, 황달

검사항목	2025	참고치
요백혈구 (urine Leukocytes)	음성	
요아질산(urine Nitrite)	음성	
요비중(urine S.G)	1.010	1.005-1.035
요산도(urine pH)	6.0	5.0-8.0
요단백(urine protein)	음성	
요당(urine glucose)	음성	
요케톤체(urine ketone body)	양성(+)	
유로빌리노겐(urobilinogen)	음성	
요빌리루빈(urine bilirubin)	음성	

요잠혈(urine occult bood)	음성	

전해질 검사

전해질은 체내 산염기의 균형에 중요한 역할을 하며, 전해질의 농도를 측정하여 주로 뼈질환, 신장질환, 내분비질환, 심장질환 등을 진단할 수 있습니다.

관련 질환 전해질대사, 부갑상선 질환

검사항목	2025	참고치
나트륨(Na) (mEq/L)	144	135-155
칼륨(K) (mEq/L)	4.2	3.5-5.5
염소(Cl) (mEq/L)	104	95-110
칼슘(Ca) (mg/dL)	9.2	8.3-11.0
인(P) (mg/dL)	3.3	2.5-5.6

감염관련혈청반응 검사

RPR은 매독 감염 유무를 평가하는 검사입니다. 양성인 경우 정밀검사가 필요하며, 과거에 치료한 경우 양성반응이 나올 수 있습니다. 그렇지만 매독과 무관한데도 양성반응 을 보이는 위양성(false positive) 반응을 보일 수 있으므로 추가검사가 필요합니다.

H.pyloi검사는 위염과 관련하여 헬리코박터균의 감염 여부를 확인할 수 있는 검사입니다.

관련 질환 매독, 후천성면역결핍증, 위·십이지장궤양

검사항목	2025	참고치
RPR(정밀)	음성	음성

성인병 및 대사관련 질환

지질대사 및 심혈관계 검사

총콜레스테롤, LDL콜레스테롤, 중성지방의 증가는 심혈관계질환의 위험이 있으므로 기준치 이하로 유지해야 되며, 반대로 HDL콜레스테롤은 심혈관질환 예방 효과가 있어 기준치보다 높게 유지해야합니다.
고지혈증을 예방하기 위해서는 식이요법과 운동요법이 매우 중요합니다.
아포지단백 A-1의 증가시 동맥경화 예방에 효과적이므로 높게 유지하는것이 좋으며, 아포지단백 B의 증가시 비만, 동맥경화, 당뇨병의 위험이 있으므로 낮게 유지하는 것이 좋습니다.

관련 질환 심근경색증, 동맥경화증, 고지혈증

검사항목	2025	참고치
크레아티닌키나제(CPK) (U/L)	95	30-250
총콜레스테롤(Total cholesterol) (mg/dL)	181	200 미만
HDL-콜레스테롤(HDL-cholesterol) (mg/dL)	51.6	40 이상
LDL-콜레스테롤(LDL-cholesterol) (mg/dL)	118	130 미만
중성지방(Triglyceride) (mg/dL)	58	200 미만

췌장기능 검사

췌장은 소화효소와 호르몬을 분비하는 기관으로 췌장염시 혈중 아밀라제가 상승합니다.

관련 질환 췌장염

검사항목	2025	참고치
아밀라제 (IU/L)	37	28-110

당뇨 검사

· 공복시혈당은 당뇨병을 검사하는 가장 기본적인 지표로 사용되며, 8시간이상 금식 후 측정한 결과로 진단합니다. 정상에서 공복혈당은 110mg 미만으로 유지되며, 110-125mg/dL 인 경우는 당뇨병 전단계(공복혈당 장애), 126mg/dL 이상일 경우 당뇨병으로 진단됩니다.

· 당화혈색소는 2~3개월 동안의 평균적인 혈당조절상태를 나타내는 검사로 정상에서 5.7%미만으로 유지되며, 5.7-6.4%인 경우 당뇨병 전단계, 6.5%이상일 경우 당뇨병으로 진단됩니다.

관련 질환 당뇨병, 공복혈당장애

검사항목	2025	참고치
공복시혈당(FBS=Glucose) (mg/dL)	80	70-110

동맥경화 검사

동맥경화검사는 팔과 다리에서 혈압과 맥압을 모니터링하여 혈관상태를 평가하는 검사입니다.
동맥의 협착이나 폐색 등 혈관합병증을 조기 발견하는데에 목적이 있으며, 결과소견에 따라 추가적인 정밀검사가 필요할 수 있습니다.

관련 질환 동맥경화, 심혈관계 질환

검사항목	2025
동맥경화 검사	동맥경화 검사 결과 맥파 전달 속도(baPWV-우:1207, 좌:1175), 동맥경화 및 동맥의 협착 정도를 나타내는 수치는(ABI-우:1.09, 좌:0.98)로 측정되었습니다. 혈관 질환 위험도는 양호한 상태입니다.

갑상선 및 내분비 관련 질환

갑상선 기능 검사

· TSH는 갑상선의 기능변화를 반영하는 가장 좋은 검사법으로 갑상선의 기능이 저하되면 증가되고, 갑상선의 기능이 항진되면 감소합니다.

· Free T4 감소는 갑상선 기능 저하증을 의심할 수 있으며, 증가시에는 갑상선 기능 항진증을 의심할 수 있습니다.

관련 질환 갑상선기능항진증, 갑상선기능저하증

검사항목	2025	참고치
갑상선자극호르몬(TSH) (uU/mL)	1.686	0.25-5.50
자유 갑상선 호르몬(FreeT4) (ng/dL)	1.04	0.8-1.9

통풍 및 염증반응 검사

· 요산은 주로 신장에서 여과되어 소변으로 배출됩니다. 요산의 생성증가나 배설 장애가 있는 경우 혈액에 축적되어 통풍, 신장 및 요로결석의 원인이 되기도 합니다.

· RF, HS-CRP, ESR검사는 전신 염증상태를 반영하는 지표입니다. RF는 류마티스 관절염에서 양성으로 나타날 수 있으나 증상이 없는 경우 큰 의미는 없습니다. CRP, ESR 상승은 감염, 자가면역질환과 악성종양 등에서 나타나지만 비염증성 질환에서 상승되기도 하므로 의사와 상의가 필요합니다.

관련 질환 통풍, 류마티스, 염증성질환

검사항목	2025	참고치
요산(uric acid) (mg/dL)	6.7	3.0-7.0
류마티스인자(RF) (IU/mL)	13.6	15 미만

골밀도 검사

골밀도 검사는 인체 특정 부위의 뼈의 밀도를 측정하는 검사입니다.
지나친 음주, 흡연, 운동부족, 칼슘섭취부족, 조기 폐경 등에서 골다공증의 발생이 높아질 수 있으며, 뼈의 밀도가 감소하여 쉽게 골절이 될 수 있습니다.

관련 질환 골다공증, 골연화증

검사항목	2025
골밀도 검사	골밀도 검사 상 정상 소견(+0.4)입니다. 골건강 유지를 위해 칼슘이 풍부한 멸치, 유제품 등의 음식을 섭취하시고 조깅, 등산, 에어로빅, 체조, 자전거타기, 계단오르기 등의 운동을 규칙적으로 하십시오.

남성정밀

전립선초음파검사는 전립선 암, 전립선 비대증 등 전립선의 형태적 이상 유무 및 크기를 측정합니다.
전립선 초음파 검사에서 이상이 없더라도 혈청 PSA가 상승되어 있거나 배뇨장애가 있을 시 비뇨기과적 진료가 필요합니다.

관련 질환 전립선비대

검사항목	2025
전립선초음파	전립선 초음파 검사상 전립선 석회화 소견입니다. 전립선 석회화는 비교적 흔한 소견이며 특별한 임상증상이 없으면 추적검사만으로도 충분합니다

위·대장 내시경 및 조영술

위검사

위조영 검사는 바륨현탁액을 경구투여한 후에 엑스선 촬영을 하여 위와 십이지장의 모양 및 병변을 모니터로 직접 보면서 검사합니다. 검사는 10분 정도 소요되며, 용종, 위간질 종양, 위염, 위 ·십이지장궤양, 위암 등의 유무를 검사합니다.

위내시경 검사는 지속되는 복통, 메스꺼움, 구토, 연하곤란 등의 증상 진단 및 식도나 위·십이지장에 발생하는 위암, 위궤양, 십이지장궤양, 식도염 등 여러 종류의 질환을 진단하는 방법입니다. 상부 소화기계의 이상을 검사하기 위해 가장 정확하고 많이 쓰이는 검사입니다.

관련 질환 위암, 위궤양, 십이지장궤양, 식도염

검사항목	2025
위내시경	위내시경 검사에서 식도, 위, 십이지장까지 관찰하였고 특이소견 관찰되지 않습니다. 속쓰림, 소화불량 등의 증상이 없으면 1년 후 정기검사 받으시기 바랍니다.

대장검사

대장내시경 검사는 항문으로 내시경을 삽입하여 대장의 내부 및 소장의 일부까지 관찰하는 검사로 필요에 따라 지혈, 조직검사, 병변제거 등의 치료목적을 동반한 검사입니다.
대장암과 염증성 장질환의 진단에 매우 중요하며, 정상인의 경우 5년마다 1번정도 검사하고, 용종발견시 1~2년 이내에 재검사를 시행하도록 권합니다.

관련 질환 대장암, 염증성 장질환

검사항목	2025
대장내시경/조영촬영	대장내시경 검사에서 특이소견이 관찰되지 않습니다.

초음파 검사

• 복부초음파 검사

복부초음파 검사는 간이나 담낭, 췌장, 신장, 비장 등의 진단에 필수적인 검사이며, 각종 암의 발견에 큰 효과가 있는 검사입니다.초음파는 인체에 해가 없고 통증이나 불편 없이 실시간으로 영상을 보면서 검사할 수 있습니다. 그러나 초음파의 특성상 볼 수 있는 장기에 한계가 있고 검사 받는 사람의 신체 특징, 장의 가스 등에 따라 검사 영역에 제한이 있을 수 있습니다. 특히 췌장은 체부와 꼬리 부분이 장내 공기에 막혀 보이지 않을 수 있습니다.

관련 질환 간암, 담낭암, 담석증, 췌장암, 신장결석, 신장암 등

검사항목	2025
상복부초음파	상복부 초음파 검사상 간, 비장, 담낭, 췌장(이자), 신장에 특이소견이 보이지 않습니다. (과거 경미한 지방간 관찰되지 않음)

• 갑상선초음파 검사

갑상선은 우리 목의 앞부분에 위치하는 큰 내분비 기관으로 갑상선 호르몬을 분비해 인체내 모든 기관의 기능을 적절하게 유지시켜 주는 역할을 합니다.
갑상선초음파 검사는 갑상선의 내부 구조와 주위 조직을 검사할 수 있습니다. 결절을 발견하고 모양을 구분할 수 있으나 악성과 양성을 정확히 진단할 수는 없으므로 결절의 크기나 모양에 따라 갑상선세침검사나 추가 검사가 필요할 수 있습니다.

초음파 검사는 대부분 2~3일 이내에 결과를 알 수 있습니다. 초음파에서 양성 결절은 낭종, 스폰지 모양으로 보입니다. 악성 결절은 현저한 저에코, 앞뒤로 긴 모양, 침상 경계, 석회화 등의 소견을 보이게 됩니다.

관련 질환 갑상선 결절

검사항목	2025
갑상선초음파	갑상선 초음파 검사상 특이소견 없습니다.

• 심장초음파 검사

심장 초음파는 초음파를 이용하여 실시간으로 심장의 움직이는 모습을 관찰할 수 있으며, 심장의 해부학적 구조의 이상, 심장 기능, 심장 내 압력 등을 실시간으로, 비침습적으로 관찰할 수 있는 검사법입니다.
심장 및 대혈관의 선천성 기형, 심장 확장, 심장근육의 비대, 심장근육 움직임의 이상, 판막질환 유무 및 정도, 심장내부와 주위의 비정상적인 구조 등을 진단할 수 있습니다. 하지만 심전도와 심장의 해부학적 기능적인 평가를 하는

심장초음파만으로는 심장 관상동맥 협착을 진단하기 어렵기 때문에 심혈관계 질환이 의심될 경우 심장 초음파 결과상 추가 검사가 필요할 경우 추가 검사를 권고하기도 합니다.

심장초음파는 환자에게 고통을 주지 않으면서 심장을 관찰할 수 있고 반복검사를 할 수 있는 편리한 검사이지만 공기, 지방, 뼈 등을 잘 투과하지 못하는 초음파의 특수성 때문에 비만환자, 폐질환이 있는 경우 좋은 영상을 얻기 어려울 수 있습니다.

관련 질환 심실 중격 결손증, 심장 판막증, 비대형 심근증, 급성 심근경색 등

검사항목	2025
심장초음파	심장 초음파 검사상 특별한 이상 소견 없습니다. 좌심실 이완기능 수축기능{박출률 67\% (정상범위 56~78\%)}은 정상범위 입니다.

MRI 검사

MRI검사는 인체를 구성하는 물질의 자기적 성질을 측정하여 컴퓨터를 이용해 재구성, 영상화하는 기술로서 근육, 인대, 뇌실질 병변(오래된 출혈), 추간판 등 연조직 병변의 진단에 활용되고 뇌의 MRI검사는 뇌종양, 퇴행성 뇌질환, 수두증, 뇌혈종 등 여러가지 병변을 확인하는데 도움이 됩니다.
인체를 단면으로 보여준다는 점에서는 CT와 유사하지만 CT에서는 인체를 가로로 자른 모양인 횡단면 영상이 위주가 되지만 MRI는 환자의 자세 변화 없이 원하는 방향에 따라 인체에 대해 횡축 방향, 세로축 방향, 사선 방향 등의 영상을 자유롭게 얻을 수 있다는 장점이 있습니다.

검사항목	2025
기타 MRI	뇌 MRI T2WI 검사 결과 뇌실질에 특이소견 보이지 않습니다.